ANA MATERYAL

50 Acil Senaryo Nöbet Protokolü

Nöbette karşınıza çıkan 50 acil tabloda hangi tetkiki önereceğinizi, görüntüyü hangi sırayla okuyacağınızı, hangi kırmızı bayrağı arayacağınızı ve uzman hocanızı ne zaman, nasıl arayacağınızı tek sayfada bulun.

İçindekiler

Bu protokol nasıl kullanılır

Bölüm 1 · Nöroradyoloji acilleri (Senaryo 1–12)

Bölüm 2 · Göğüs acilleri (Senaryo 13–22)

Bölüm 3 · Batın ve pelvis acilleri (Senaryo 23–36)

Bölüm 4 · Travma (Senaryo 37–44)

Bölüm 5 · Pediatri ve gebelik (Senaryo 45–50)

Sonraki adım

BAŞLARKEN

Bu protokol nasıl kullanılır

50 senaryo, her biri aynı altı başlıkla: klinik tablo, tetkik seçimi, okuma sırası, kırmızı bayraklar, arama zamanı ve rapora yazılacaklar.

> *Nöbette en zor an, ekranda bir görüntü ve kafanızda bir soru varken yanınızda kimsenin olmadığı andır. Bu protokol o an için yazıldı: ne yapacağınızı bilin, kimi ne zaman arayacağınızı bilin.*

Her senaryoda aynı altı başlık

BAŞLIK	SİZE NE SÖYLER
Klinik tablo	Hangi hastada bu senaryoyu düşünmelisiniz.
Hangi tetkik?	İlk tetkik ve nedeni; USG, BT veya MR'ın hangi durumda öne geçtiği.
Okuma sırası	Görüntüyü her seferinde aynı sırayla okumanız için numaralı adımlar.
Kırmızı bayraklar	Gördüğünüz anda durumu acil hâle getiren bulgular.
Uzman hocanızı ne zaman aramalısınız	Beklemeden aramanız gereken durumlar.
Rapora mutlaka yazın	Raporda eksik kalmaması gereken ifadeler.

Her okumada 4 adımlı metot

1. **HAZIRLA** — Belirleyin (doğru hasta, doğru tetkik, tarih, protokol), kaliteyi kontrol edin (teknik yeterlilik), yönlenin (taraf, kesit, pencere veya sekans).
2. **TARA** — Her bölgeyi her seferinde aynı sırayla tarayın. İlk bulguda durmayın.
3. **TANIMLA** — Doğru terimlerle (dansite, sinyal, ekojenite), lokalizasyon, boyut ve sınırla tanımlayın; eski tetkik ve karşı tarafla karşılaştırın.
4. **ÖZETLE** — Sonuç cümlesi, ayırıcı tanı, öneri. Acil bulguyu klinisyene bildirin ve bildirimi kaydedin.

Kurum protokolü her zaman önce gelir

Bu materyaldeki tetkik seçimleri genel yaklaşımlardır. Çalıştığınız hastanenin protokolü, uzman hocanızın yönlendirmesi ve hastanın klinik durumu her zaman önceliklidir. Emin olmadığınız her durumda sormak bir zayıflık değil, hasta güvenliğidir.

Arama eşiğiniz düşük olsun

Birinci yıl asistanı olarak «hocamı gereksiz yere rahatsız ederim» kaygısı normaldir. Bu protokoldeki «Uzman hocanızı ne zaman aramalısınız» başlıkları, beklemeden aramanız gereken anları netleştirir. Aramadan önce neyi hazır tutacağınızı Bonus 1'de bulacaksınız.

BÖLÜM 1

Nöroradyoloji acilleri

Senaryo 1–12 · Kanama, inme, kafa içi basınç, enfeksiyon ve spinal acil.

Senaryo 01 NÖRO

Ani başlayan, hayatının en şiddetli baş ağrısı

Klinik tablo: Saniyeler içinde zirveye ulaşan baş ağrısı; bulantı, ense sertliği veya kısa süreli bilinç kaybı eşlik edebilir. Subaraknoid kanama (SAK) dışlanmalıdır.

HANGİ TETKİK?

Kontrastsız beyin BT ilk tetkiktir: hızlıdır ve akut kanayı hiperdens olarak gösterir. SAK görülürse anevrizma araştırması için BT anjiyografi klinik ekip ve uzman hocanızla birlikte planlanır. BT negatif ama şüphe sürüyorsa sonraki adım (LP veya ileri görüntüleme) klinik ekiple belirlenir.

OKUMA SIRASI

1. Bazal sisternler: suprasellar, perimezensefalik, interpedünküler. Normalde siyah ve simetriktir.
2. Silvian fissürler ve interhemisferik fissür.
3. Lateral ventriküllerin oksipital boynuzları: sedimante kan.
4. Vertekse kadar kortikal sulkuslar.
5. Ventrikül boyutu ve temporal boynuzlar: erken hidrosefali.
6. Parankimal hematom, kitle etkisi, orta hat.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Akut hidrosefali · intraventriküler kan · parankim içi hematom · herniasyon bulguları

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

SAK'tan şüphelendiğiniz anda. Görüntü negatif ama klinik şüphe çok yüksekse de görüşün.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Kanın dağılımı (sisternler, fissürler, ventriküller), hidrosefali var/yok, kitle etkisi, BT anjiyografi önerisi, bildirimin kime ve ne zaman yapıldığı.

Senaryo 02 NÖRO

Akut inme şüphesi: kod inme

Klinik tablo: Ani başlayan yüzde asimetri, kol veya bacakta güçsüzlük, konuşma bozukluğu. Semptom başlangıç zamanı biliniyor; hasta akut tedavi adayı olabilir.

HANGİ TETKİK?

Kontrastsız beyin BT önce gelir: kanamayı dışlamak tedavi kararının ilk koşuludur. Kurum protokolüne göre BT anjiyografi (büyük damar oklüzyonu) ve gerekirse perfüzyon eklenir. MR (DAG) bazı merkezlerde seçilmiş hastada kullanılır; zaman kaybettirmemelidir.

OKUMA SIRASI

1. Önce kanama: parankim, ekstraaksiyel aralıklar, ventriküller.
2. Hiperdens arter: MCA, baziler arter.
3. Erken iskemi: insular kurdele, lentiform çekirdek sınırı, gri-beyaz cevher ayrımının silinmesi (dar inme penceresi).
4. Kitle, tümör veya inmeyi taklit eden başka neden.
5. BTA varsa: intrakraniyal büyük damarlar, sonra boyun damarları ve arkus.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Herhangi bir kanama · büyük damar oklüzyonu · geniş alanda erken iskemi · posterior sistem tutulumu

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Kod inme açıldığında, okumayı beklemeden haberdar edin. Kanama, oklüzyon veya emin olamadığınız erken iskemi gördüğünüzde hemen arayın.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Kanama var/yok (ilk cümle), hiperdens arter, erken iskemik değişikliklerin yeri, oklüzyon seviyesi (BTA varsa), bildirim saati.

Senaryo 03 NÖRO

Uyandığında fark edilen inme: başlangıç zamanı bilinmiyor

Klinik tablo: Hasta sabah defisitle uyanmış veya en son ne zaman normal görüldüğü belli değil.

HANGİ TETKİK?

Kanamayı dışlamak için yine kontrastsız BT ile başlanır. Zamanı bilinmeyen hastada doku temelli seçim için kurumun protokolüne göre MR (DAG ve FLAIR) veya BT perfüzyon istenebilir. Hangi yolun izleneceğine nöroloji ekibi ve uzman hocanız birlikte karar verir.

OKUMA SIRASI

1. Kanama dışlama (Senaryo 02 sırası).
2. BT'de belirgin hipodansite: yerleşik enfarkt düşündürür.
3. MR varsa: DAG'da kısıtlanma alanı ve ADC karşılığı.
4. Aynı alanın FLAIR görünümü: DAG ile FLAIR uyumunu not edin.
5. Damar görüntülemesi varsa oklüzyon seviyesi.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Geniş enfarkt ve kitle etkisi · posterior fossada şişme ve dördüncü ventrikül basısı · hemorajik dönüşüm

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Tetkik seçimi netleşmeden önce ve DAG/FLAIR uyumunu yorumlamakta emin olmadığınız her durumda.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Kanama var/yok, enfarktın yeri ve yaygınlığı, DAG ile FLAIR ilişkisi, kitle etkisi, damar bulgusu.

Senaryo 04 NÖRO

Yaşlı hastada bilinç bulanıklığı: subdural hematom şüphesi

Klinik tablo: Antikoagülan veya antiagregan kullanan yaşlı hasta; günler içinde artan konfüzyon, düşme öyküsü olabilir veya olmayabilir.

HANGİ TETKİK?

Kontrastsız beyin BT. Subakut subdural hematom beyinle izodens olabilir; bu durumda dolaylı bulgulara güvenirsiniz. MR belirsiz olgularda sonra planlanabilir, acil ilk basamak değildir.

OKUMA SIRASI

1. Konveksiteleri iki taraflı karşılaştırın: kalvaryuma bitişik hilal şeklinde koleksiyon.
2. Falks ve tentoryum boyunca ince hiperdens tabaka.
3. Geniş pencere (subdural pencere) ile kalvaryum komşuluğuna yeniden bakın.
4. Sulkusların bir tarafta silinmesi, ventrikül basısı, orta hat kayması.
5. Karışık dansite: kronik zemin üzerinde akut kanama.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Orta hat kayması · bazal sisternlerin silinmesi · bilateral koleksiyon (kayma olmadan basınç) · koleksiyon içinde yeni kanama

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Kitle etkisi olan her subdural hematomda ve izodens koleksiyondan şüphelendiğiniz ama emin olamadığınız durumda.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Taraf, yaygınlık, dansite (akut / subakut / kronik / karışık), en kalın yerdeki kalınlık, orta hat kayması, herniasyon bulguları, karşılaştırma yapıldıysa değişim.

Senaryo 05 NÖRO

Hipertansif hastada ani defisit: intraserebral hemoraji

Klinik tablo: Ani başlayan hemiparezi, baş ağrısı, kusma, bilinçte hızlı kötüleşme; çoğu zaman yüksek tansiyon.

HANGİ TETKİK?

Kontrastsız beyin BT. Hematomun yeri tipik değilse, hasta gençse veya altta yatan vasküler lezyon şüphesi varsa BT anjiyografi önerilebilir; kararı uzman hocanız ve klinik ekiple verin.

OKUMA SIRASI

1. Hematomun yeri: bazal ganglion, talamus, lob, beyin sapı, serebellum.
2. Hacim için üç düzlemde ölçü.
3. Ventriküle açılım ve hidrosefali.
4. Çevre ödem, kitle etkisi, orta hat kayması, herniasyon.
5. Tipik olmayan özellikler: lob yerleşimi, sıvı-sıvı seviyesi, altta kitle görünümü.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Serebellar hematom · intraventriküler yayılım ve hidrosefali · herniasyon · antikoagülan kullanımı

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Her yeni intraserebral hematomda; özellikle posterior fossa yerleşiminde ve hidrosefali varlığında beklemeden.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Yer, üç boyutlu ölçüler, ventriküle açılım, hidrosefali, kitle etkisi, orta hat kayması, ek inceleme önerisi.

Senaryo 06

NÖRO

Bilinen kitle, baş ağrısı ve kusma: herniasyon riski

Klinik tablo: Bilinen beyin tümörü veya metastazı olan hastada artan baş ağrısı, kusma, bilinçte azalma.

HANGİ TETKİK?

Acilde kontrastsız BT kitle etkisini, kanamayı ve hidrosefaliyi hızla gösterir. Kontrastlı MR lezyonun karakterizasyonu için daha değerlidir, ancak hasta stabil değilse beklemelidir.

OKUMA SIRASI

1. Lezyon ve çevre vazojenik ödem.
2. Lezyon içi kanama.
3. Orta hat kayması ve subfalsin herniasyon.
4. Unkal herniasyon: suprasellar sisternin asimetrisi, temporal lob medial kenarı.
5. Tonsiller seviye ve dördüncü ventrikül.
6. Ventriküllerde tıkanma tipi hidrosefali.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Herhangi bir herniasyon bulgusu · yeni kanama · obstrüktif hidrosefali

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Eski tetkike göre kitle etkisinde artış, herniasyon veya hidrosefali gördüğünüz anda.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Eski tetkikle karşılaştırma (tarih), ödemde ve kaymada değişim, herniasyon tipi, hidrosefali, kanama.

Senaryo 07

NÖRO

Ventrikülоperitoneal şantı olan hasta: şant disfonksiyonu

Klinik tablo: Şantlı hastada baş ağrısı, kusma, uykuya eğilim; çocuklarda huzursuzluk ve beslenme bozukluğu.

HANGİ TETKİK?

Kontrastsız beyin BT (çocuklarda kurumun düşük doz veya hızlı MR protokolü olabilir) ve şant hattını gösteren direkt grafi serisi. En değerli araç eski tetkikle karşılaştırmadır.

OKUMA SIRASI

1. Ventrikül boyutunu eski tetkikle yan yana karşılaştırın.
2. Temporal boynuzlar ve üçüncü ventrikül.
3. Periventriküler hipodansite: transependimal akım.
4. Kateter ucunun yeri.
5. Şant serisinde hat boyunca kopukluk, kıvrılma, yer değiştirme.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Ventriküllerde artış · transependimal ödem · şant hattında kopukluk · yeni kanama

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Ventrikül boyutunda artış veya hat bütünlüğünde bozulma gördüğünüzde. Eski tetkik yoksa ve karar veremiyorsanız da arayın.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Karşılaştırılan tetkikin tarihi, ventrikül boyutundaki değişim, kateter ucu, şant hattının bütünlüğü.

Senaryo 08 NÖRO

Ateş, baş ağrısı, ense sertliği: lomber ponksiyon öncesi BT

Klinik tablo: Menenjit veya ansefalit şüphesi; klinik ekip LP öncesinde görüntüleme istemiş.

HANGİ TETKİK?

Kontrastsız beyin BT: LP'yi riskli hâle getirebilecek kitle etkisini, kanamayı ve hidrosefaliyi araştırır. Ansefalit, apse veya komplikasyon şüphesinde kontrastlı MR daha duyarlıdır; zamanlamayı klinik ekip belirler.

OKUMA SIRASI

1. Kitle etkisi, orta hat, bazal sisternler.
2. Hidrosefali.
3. Temporal loblarda hipodansite (ansefalit lehine olabilir).
4. Apse veya ampiyem: ekstraaksiyel koleksiyon.
5. Kemik penceresinde sinüsler ve mastoidler: kaynak araştırması.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Kitle etkisi veya herniasyon (LP öncesinde mutlaka bildirin) · subdural ampiyem · apse · hidrosefali

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

LP'yi etkileyebilecek her bulguda ve ansefalitten şüphelendiğinizde MR planı için.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

«LP'yi kontrendike kılabilecek kitle etkisi, herniasyon bulgusu, hidrosefali» var/yok cümlesi açıkça; sinüs ve mastoid durumu; MR önerisi gerekiyorsa.

Senaryo 09 NÖRO

İlk kez nöbet geçiren erişkin

Klinik tablo: Daha önce nöbet öyküsü olmayan erişkinde jeneralize veya fokal nöbet; nöbet sonrası düzelme hızı değişken.

HANGİ TETKİK?

Acilde kontrastsız BT kanama, kitle ve travmayı hızla dışlar. Epilepsi açısından ayrıntılı değerlendirme için MR daha değerlidir ve çoğu zaman elektif planlanır. Fokal defisit kalıcıysa inme protokolünü düşünün.

OKUMA SIRASI

1. Kanama ve kontüzyon (nöbet sırasında düşme).
2. Kitle, ödem, kalsifikasyon.
3. Hipokampus ve temporal loblar.
4. Kortikal yerleşimli hipodansite: enfarkt veya venöz enfarkt.
5. Kemik penceresinde kalvaryum kırığı.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Kanama · kitle ve ödem · kalıcı fokal defisitle uyumlu iskemi · venöz tromboz düşündüren bulgular

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Yeni kitle, kanama veya venöz sinüs trombozu şüphesinde.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Akut patoloji var/yok, travmatik bulgu, MR önerisi (endikasyonla birlikte).

Senaryo 10 NÖRO

Ani baş dönmesi, ataksi, çift görme: posterior sistem

Klinik tablo: Vertigo, yürüyememe, dizartri, diplopi veya bilinç değişikliği; tablo bazen periferik vertigoyla karışır.

HANGİ TETKİK?

Kontrastsız BT kanamayı dışlar ama posterior fossada erken iskemiye duyarsızdır; kemik artefaktı değerlendirmeyi zorlaştırır. Kurum protokolüne göre BT anjiyografi (baziler ve vertebral arterler) ve MR (DAG) planlanır.

OKUMA SIRASI

1. Serebellum ve beyin sapı: kanama, hipodansite.
2. Hiperdens baziler arter.
3. Dördüncü ventrikül basısı ve hidrosefali.
4. BTA'da baziler ve vertebral arter devamlılığı.
5. MR varsa DAG'da serebellar ve beyin sapı kısıtlanması.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Baziler arter oklüzyonu · serebellar enfarktta şişme · dördüncü ventrikül basısı · hidrosefali

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Baziler oklüzyon şüphesinde beklemeden. BT normal ama klinik posterior sistemi düşündürüyorsa ileri tetkik planı için.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

BT'nin posterior fossada sınırlı duyarlılığını belirten cümle, damar bulguları, kitle etkisi, MR önerisi.

Senaryo 11

NÖRO

Giderek artan baş ağrısı: serebral venöz sinüs trombozu

Klinik tablo: Günler içinde artan baş ağrısı, kusma, görme bulanıklığı, nöbet veya fokal defisit; lohusalık, oral kontraseptif, dehidratasyon gibi risk durumları.

HANGİ TETKİK?

Kontrastsız BT ilk basamaktır ama normal olabilir. Şüphe sürüyorsa BT venografi veya MR venografi kurumun protokolüne göre istenir.

OKUMA SIRASI

1. Dural sinüsler ve kortikal venler: beklenenden hiperdens damar.
2. Arteriyel alana uymayan hipodansite veya kanama (venöz enfarkt).
3. Bilateral, parasagital veya talamik tutulum.
4. Kontrastlı incelemede sinüs içinde dolum defekti.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Venöz enfarkt ve kanama · derin venöz sistem tutulumu · kitle etkisi

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Venöz sinüs trombozundan şüphelendiğinizde, venografi protokolüne karar vermek için.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Tutulan sinüsler, parankim bulguları, kanama, venografi önerisi.

Senaryo 12

NÖRO · OMURGA

Sırt ağrısı, bacaklarda güçsüzlük, idrar retansiyonu

Klinik tablo: Spinal kord basısı veya kauda ekina sendromu şüphesi; bilinen malignite, enfeksiyon veya travma öyküsü olabilir.

HANGİ TETKİK?

MR seçilecek tetkiktir: kord, kauda, disk, epidural alan ve kemik iliği tek incelemede görülür. Malignite öyküsünde kurumun protokolüne göre tüm omurga taranabilir. MR yapılamıyorsa alternatif yol uzman hocanız ve klinik ekiple belirlenir.

OKUMA SIRASI

1. Sagital T2'de tüm hattın genel taraması: kordun veya kaudanın seviyesi.
2. Sagital T1'de kemik iliği: metastaz, kırık.
3. Epidural alan: kitle, apse, hematom, büyük disk.
4. Aksiyel kesitlerle bası seviyesini doğrulayın.
5. Kordda T2 sinyal artışı.
6. Kontrastlı seri varsa epidural apse ve kenar boyanması.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Kord veya kauda basısı · epidural apse · birden fazla seviyede tutulum · patolojik kırık

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

MR istemi geldiğinde protokol için ve bası gördüğünüz anda, raporu bitirmeden.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Bası seviyesi ve nedeni, kord sinyali, tüm omurgada başka seviye var/yok, bildirim saati.

BÖLÜM 2

Göğüs acilleri

Senaryo 13–22 · Emboli, aort, pnömotoraks, tüpler, solunum yetmezliği.

Senaryo 13 GÖĞÜS

Ani dispne ve plöretik ağrı: pulmoner emboli şüphesi

Klinik tablo: Ani nefes darlığı, taşikardi, göğüs ağrısı, hipoksi; immobilizasyon, cerrahi, malignite veya DVT öyküsü.

HANGİ TETKİK?

BT pulmoner anjiyografi standart tetkiktir. Gebelerde ve kontrast verilemeyen hastada yol (perfüzyon sintigrafisi, alt ekstremite Doppler USG) kurumun protokolüne göre uzman hocanızla belirlenir. Bacakta DVT bulgusu varsa Doppler USG tanıya yardım edebilir.

OKUMA SIRASI

1. Kontrast kalitesi: pulmoner trunkusta yeterli opasifikasyon var mı?
2. Ana pulmoner arterlerden başlayıp lobar, segmenter, subsegmenter dallara her iki tarafta sırayla inin.
3. Dolum defekti: merkezi, eksantrik, tıkayıcı.
4. Sağ kalp yüklenmesi: sağ ventrikül / sol ventrikül oranı, septumun düzleşmesi, kontrastın hepatik venlere reflüsü.
5. Akciğer penceresi: enfarkt, efüzyon, alternatif tanı.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Sağ ventrikül yüklenme bulguları · ana arterlerde veya bifurkasyonda (eyer) trombus · yetersiz kontrast nedeniyle tanısal olmayan inceleme

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Sağ kalp yüklenmesi bulgusu olan her emboli ve incelemenin tanısal olup olmadığından emin olmadığınız durumda.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Teknik yeterlilik, embolinin en proksimal seviyesi ve yaygınlığı, sağ kalp yüklenmesi bulguları, alternatif tanı, bildirim saati.

Senaryo 14 GÖĞÜS

Yırtılır tarzda göğüs veya sırt ağrısı: akut aort sendromu

Klinik tablo: Ani, şiddetli, sırta yayılan ağrı; kollar arası tansiyon farkı, nabız asimetrisi, nörolojik defisit veya senkop eşlik edebilir.

HANGİ TETKİK?

BT aortografi seçilecek tetkiktir; kurum protokolüne göre kontrastsız seri (intramural hematom için) ve arteriyel faz birlikte alınır. Hemodinamik olarak stabil olmayan hastada yatak başı ekokardiyografi klinik ekip tarafından değerlendirilebilir.

OKUMA SIRASI

1. Kontrastsız seride aort duvarında hilal şeklinde hiperdens kalınlaşma (intramural hematom).
2. Arteriyel fazda intimal flep: asendan aorttan başlayın.
3. Diseksiyonun başladığı ve bittiği yer: asendan aort tutulumu var mı?
4. Dal damarlar: arkus dalları, çölyak, SMA, renal arterler; hangi lümenden besleniyor.
5. Perikardiyal ve plevral efüzyon, mediastinal hematom.
6. Organ perfüzyonu: barsak, böbrekler.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Asendan aort tutulumu · hemoperikard · rüptür bulgusu · dal damar oklüzyonu ve organ iskemisi

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Akut aort sendromu gördüğünüz anda, raporu yazmadan önce. Asendan aort tutulumu en acil durumdur.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Diseksiyonun başlangıç ve bitiş noktası, asendan aort tutulumu (açıkça var/yok), dal damar durumu, efüzyonlar, organ iskemisi, bildirim saati.

Senaryo 15 GÖĞÜS

Genç hastada ani göğüs ağrısı: spontan pnömotoraks

Klinik tablo: Ani plöretik ağrı ve nefes darlığı; sıklıkla uzun boylu, ince, sigara içen genç veya altta akciğer hastalığı olan hasta.

HANGİ TETKİK?

Ayakta PA akciğer grafisi ilk tetkiktir. Yatak başında USG (akciğer kayması, A çizgileri, akciğer noktası) hızlı destek sağlar. BT; komplike olguda, altta yatan akciğer hastalığında veya grafi belirsizse düşünülür.

OKUMA SIRASI

1. Apeksleri büyüterek inceleyin: ince beyaz visseral plevra çizgisi.
2. Çizginin dışında akciğer damarlanmasının olmaması.
3. Kostaların ve skapula kenarının plevra çizgisiyle karışmaması.
4. Mediasten ve trakeanın yeri.
5. Altta yatan bül, kitle, efüzyon.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Mediastinin karşı tarafa itilmesi · diyaframın düzleşmesi · bilateral pnömotoraks · hemopnömotoraks

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Tansiyon bulgusu, bilateral tutulum veya ekstra hava (pnömomediastinum) gördüğünüzde.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Taraf, yaygınlık (apikal / tüm hemitoraks boyunca), mediastinal kayma var/yok, eşlik eden bulgu, bildirim.

Senaryo 16 GÖĞÜS

Ventilatördeki hastada ani desatürasyon

Klinik tablo: Yoğun bakımda mekanik ventilasyondaki hastada ani oksijen düşüşü, hava yolu basıncında artış, hipotansiyon.

HANGİ TETKİK?

Yatak başı akciğer grafisi; yatak başı USG pnömotoraksı hızlı ayırt etmede yardımcıdır. Tansiyon pnömotoraks klinik bir tanıdır: görüntüleme tedaviyi geciktirmemelidir.

OKUMA SIRASI

1. Endotrakeal tüp ucu: ana bronşa ilerleme (tek akciğer ventilasyonu) var mı?
2. Sırtüstü grafide pnömotoraks: derin sulkus işareti, keskinleşmiş kalp kenarı, üst karında hiperlusensi.
3. Mediastinal kayma.
4. Yeni gelişen atelektazi veya total opasite (mukus tıkacı).
5. Diğer tüp ve kateterler.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Tansiyon bulguları · ETT'nin ana bronşta olması · tüm hemitoraksın opaklaşması

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Pnömotoraks veya tüp malpozisyonu gördüğünüzde önce klinisyeni hemen bilgilendirin, ardından uzman hocanızı haberdar edin.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Pnömotoraks var/yok, ETT ucunun yeri, mediastinal kayma, yeni opasite, bildirim saati ve kime yapıldığı.

Senaryo 17 GÖĞÜS

Yoğun bakım grafisi: tüp ve kateter kontrolü

Klinik tablo: Yeni takılmış endotrakeal tüp, santral venöz kateter, nazogastrik tüp veya göğüs tüpü için kontrol grafisi.

HANGİ TETKİK?

Yatak başı akciğer grafisi. Nazogastrik tüp için gerekirse üst karnı da içeren grafi istenir. Konum belirsizse grafinin tekrarı veya ek projeksiyon klinisyenle konuşulur.

OKUMA SIRASI

1. Her tüpü ayrı ayrı baştan uca izleyin.
2. ETT: ucun karinaya göre konumu.
3. SVK: seyri, ucun yeri, arteriyel veya ekstravasküler seyir şüphesi.
4. NG tüp: özofagus boyunca orta hatta inip diyaframı geçmesi ve ucun midede olması; bronşa girip girmediği.
5. Her işlemden sonra pnömotoraks kontrolü.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- NG tüpün bronş ağacında olması · ETT'nin ana bronşta veya özofagusta olması · kateter sonrası pnömotoraks · beklenmedik kateter seyri

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Hava yoluna girmiş NG tüp veya arteriyel seyir şüphesi olan kateterde; klinisyeni hemen bilgilendirin.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Her cihazın adı ve ucunun anatomik yeri, malpozisyon varsa açıkça, pnömotoraks var/yok, bildirim.

Senaryo 18 GÖĞÜS

Hemoptizi

Klinik tablo: Kanlı balgam veya ağızdan kan gelmesi; tüberküloz, bronşektazi, malignite öyküsü olabilir. Masif hemoptizi hayatı tehdit eder.

HANGİ TETKİK?

Akciğer grafisi ilk basamaktır. Kanama kaynağı ve damar haritası için kontrastlı toraks BT veya BT anjiyografi kurum protokolüne göre istenir; girişimsel tedavi planlanacaksa bronşiyal arterlerin gösterilmesi önemlidir.

OKUMA SIRASI

1. Akciğer penceresi: kitle, kavite, bronşektazi, buzlu cam (aspire kan).
2. Kanamanın tarafını ve lobunu belirleyen bulgular.
3. Mediasten penceresi: genişlemiş bronşiyal arterler.
4. Pulmoner arter psödoanevrizması veya arteriyovenöz malformasyon.
5. Lenf nodları, efüzyon.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Masif kanama klinikte · kavite içinde vasküler yapı · psödoanevrizma · bilateral yaygın aspirasyon

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Masif hemoptizide BT protokolünü seçmeden önce ve girişimsel tedavi gerekebilecek bulgu gördüğünüzde.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Olası kanama tarafı ve kaynağı, altta yatan lezyon, bronşiyal arterlerin durumu, aspirasyon yaygınlığı.

Senaryo 19 GÖĞÜS

Akut nefes darlığı: pulmoner ödem mi, pnömoni mi?

Klinik tablo: Yaşlı hastada ani dispne, ortopne, raller; ateş ve öksürük varsa pnömoni de ayırıcı tanıdadır.

HANGİ TETKİK?

Akciğer grafisi ilk basamaktır. Yatak başı akciğer USG'si (B çizgileri, efüzyon) klinik değerlendirmeyi destekler. BT ilk basamak değildir; alternatif tanı (emboli, malignite) düşünülüyorsa gündeme gelir.

OKUMA SIRASI

1. Kalp boyutu ve kardiyotorasik oran (PA grafide).
2. Vasküler redistribüsyon, peribronşiyal manşon, Kerley B çizgileri.
3. Perihiler, iki taraflı simetrik opasiteler (ödem lehine).
4. Tek taraflı lobar konsolidasyon ve hava bronkogramı (pnömoni lehine).
5. Plevral efüzyon ve kostofrenik sinüsler.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Yaygın bilateral opasite ve ağır hipoksi · tek taraflı beyaz akciğer · mediastinal genişleme · pnömotoraks

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Grafi kliniğe uymuyorsa, beklenmedik kitle veya mediastinal genişleme varsa.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Kalp boyutu, ödem bulguları, konsolidasyonun yeri, efüzyon, varsa eski grafiyle karşılaştırma.

Senaryo 20 GÖĞÜS

İmmünsüpresif hastada ateş ve akciğer infiltratı

Klinik tablo: Kemoterapi, transplant, uzun süreli steroid veya HIV öyküsü; ateş, öksürük, hipoksi. Grafi normal olabilir.

HANGİ TETKİK?

Akciğer grafisi ile başlanır; grafi normal veya belirsizse ince kesit toraks BT değerlidir. Kontrast gerekip gerekmediğini endikasyona göre uzman hocanızla belirleyin.

OKUMA SIRASI

1. Buzlu cam alanları ve dağılımı.
2. Nodüller: çevresinde buzlu cam halesi, kavitasyon.
3. Konsolidasyon ve hava bronkogramı.
4. Ağaç tomurcuğu görünümü.
5. Efüzyon, lenf nodu, perikard.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Hızla yayılan bilateral buzlu cam · kaviteleşen nodüller · pnömotoraks · yaygın konsolidasyon

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Fırsatçı enfeksiyonu düşündüren bulguda ve ayırıcı tanıyı daraltamadığınızda.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Patern (buzlu cam, nodül, konsolidasyon), dağılım, kavitasyon, ayırıcı tanı listesi, eski tetkikle karşılaştırma.

Senaryo 21 GÖĞÜS

Şiddetli kusma sonrası göğüs ağrısı: özofagus perforasyonu

Klinik tablo: Kusma, endoskopi veya yabancı cisim sonrası göğüs ağrısı, ciltaltı amfizem, ateş.

HANGİ TETKİK?

Akciğer grafisi pnömomediastinumu gösterebilir ama normal olabilir. BT, oral kontrast eklenerek veya eklenmeden, kurum protokolüne göre seçilir; protokolü uzman hocanızla belirleyin.

OKUMA SIRASI

1. Mediastende, özofagus çevresinde serbest hava (akciğer penceresi).
2. Boyun ve göğüs duvarında ciltaltı amfizem.
3. Özofagus duvarında kalınlaşma, çevre yağlı dokuda kirlenme.
4. Oral kontrast verildiyse lümen dışına kaçış.
5. Plevral efüzyon ve hidropnömotoraks.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Mediastinal hava ve sıvı · kontrast ekstravazasyonu · hidropnömotoraks · mediastinal koleksiyon

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Protokol seçiminde ve pnömomediastinum gördüğünüz anda.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Serbest havanın yeri ve yaygınlığı, kontrast kaçağı var/yok, koleksiyon, efüzyon, bildirim.

Senaryo 22 GÖĞÜS

Ateş ve tek taraflı plevral sıvı: ampiyem şüphesi

Klinik tablo: Pnömoniye rağmen düşmeyen ateş, plöretik ağrı, grafide efüzyon.

HANGİ TETKİK?

Grafi efüzyonu gösterir; USG sıvının yapısını (septasyon, ekojenite) ve ponksiyon yerini göstermede çok değerlidir. Kontrastlı toraks BT plevral kalınlaşma ve kontrastlanmayı, akciğer apsesini ve ayırıcı tanıyı netleştirir.

OKUMA SIRASI

1. Efüzyonun yaygınlığı ve mediastinal kayma.
2. USG'de septasyon, lokülasyon, ekojenik içerik.
3. BT'de visseral ve paryetal plevrada kontrastlanma ve kalınlaşma.
4. Sıvı içinde gaz.
5. Komşu akciğerde apse veya konsolidasyon.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Mediastinal kayma yapan efüzyon · sıvı içinde gaz (bronkoplevral fistül olabilir) · lokülasyon

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Lokülasyon veya gaz içeren koleksiyonda, drenaj planı için.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Taraf, yaygınlık, lokülasyon, plevral kalınlaşma ve kontrastlanma, akciğer bulgusu, drenaj için uygun pencere.

BÖLÜM 3

Batın ve pelvis acilleri

Senaryo 23–36 · Perforasyon, obstrüksiyon, iskemi, damar, safra, böbrek, torsiyon.

Senaryo 23 BATIN

Ani şiddetli karın ağrısı ve defans: perforasyon

Klinik tablo: Peptik ülser öyküsü, NSAİİ kullanımı, divertikülit veya yakın zamanda endoskopi; tahta karın.

HANGİ TETKİK?

Ayakta akciğer grafisi diyafram altı serbest havayı gösterebilir ama normal olması perforasyonu dışlamaz. Kontrastlı batın BT perforasyonun yerini ve nedenini göstermede seçilecek tetkiktir.

OKUMA SIRASI

1. Akciğer penceresiyle tüm batını tarayın: karaciğer önü, ligamentum teres çevresi, mezenter.
2. Serbest havanın en yoğun olduğu bölge: kaynağa işaret eder.
3. Duvar defekti, duvar kalınlaşması, çevre yağlı dokuda kirlenme.
4. Serbest sıvı ve koleksiyon.
5. Retroperitoneal hava (duodenum, rektum kaynaklı).

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Yaygın serbest hava · fekal içerik veya oral kontrast kaçağı · apse · sepsis bulguları klinikte

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Serbest hava gördüğünüz her durumda; az miktarda ve yeri belirsiz havada da.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Serbest hava var/yok ve yeri, olası perforasyon yeri, koleksiyon, serbest sıvı, bildirim saati.

Senaryo 24 BATIN

Sağ alt kadran ağrısı: erişkinde akut apandisit

Klinik tablo: Göbek çevresinden sağ alt kadrana göç eden ağrı, iştahsızlık, ateş, McBurney hassasiyeti.

HANGİ TETKİK?

Zayıf hastalarda ve gençlerde USG ilk seçenek olabilir. Erişkinde tanı belirsizse veya komplikasyon düşünülüyorsa BT seçilecek tetkiktir. Gebelikte Senaryo 49'a bakın.

OKUMA SIRASI

1. Çekumu bulun, oradan apendiksi başından ucuna kadar izleyin.
2. Çap, duvar kalınlığı ve kontrastlanma.
3. Apendikolit.
4. Periapendiküler yağ dokusunda kirlenme, serbest sıvı.
5. Duvar bütünlüğünde bozulma, ekstralüminal hava, apse.
6. Alternatif tanılar: terminal ileum, sağ kolon, over, üreter.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Perforasyon bulguları · periapendiküler apse · portal vende gaz veya tromboz

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Komplike apandisitte ve apendiksi bütünüyle izleyemediğiniz belirsiz olgularda.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Apendiks görüldü/görülmedi, çap ve duvar, apendikolit, perforasyon ve apse var/yok, alternatif tanı.

Senaryo 25 BATIN

Kusma, distansiyon, gaz-gaita çıkaramama: ince barsak obstrüksiyonu

Klinik tablo: Geçirilmiş cerrahi (bridler), herni veya bilinen tümör; kolik tarzda ağrı.

HANGİ TETKİK?

Ayakta direkt batın grafisi dilate ince barsak anslarını ve hava-sıvı seviyelerini gösterebilir. Kontrastlı BT geçiş noktasını, nedeni ve komplikasyonları (strangülasyon, iskemi) göstermede seçilecek tetkiktir.

OKUMA SIRASI

1. Dilate ve kollabe ansları ayırın.
2. Geçiş noktasını bulun: dilate anstan kollabe ansa izleyin.
3. Neden: brid, herni (tüm herni kapılarına bakın), tümör, invajinasyon.
4. Kapalı loop bulguları: C veya U şekilli ans, mezenterde girdap.
5. İskemi: duvar kontrastlanmasında azalma, duvar ödemi, mezenterik sıvı, pnömatozis.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Kapalı loop · strangülasyon ve iskemi bulguları · pnömatozis · portal venöz gaz

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Kapalı loop, iskemi bulgusu veya geçiş noktasını bulamadığınız durumda.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Obstrüksiyon var/yok, geçiş noktasının yeri, olası neden, kapalı loop ve iskemi bulguları (açıkça var/yok).

Senaryo 26

BATIN

Yaşlı hastada belirgin distansiyon: kalın barsak obstrüksiyonu ve volvulus

Klinik tablo: Yatağa bağımlı, kronik kabız yaşlı hastada ileri derecede distansiyon; gaz ve gaita çıkaramama.

HANGİ TETKİK?

Direkt batın grafisi sigmoid volvulusu düşündüren dev ansı gösterebilir. Kontrastlı BT tanıyı doğrular, nedeni (tümör, volvulus) ve iskemiyi değerlendirir.

OKUMA SIRASI

1. Kolonu rektumdan çekuma kadar izleyin.
2. Geçiş noktası ve neden: kitle, volvulus, fekalom.
3. Volvulusta mezenterde girdap ve gagalanma.
4. Çekum çapı ve duvarı.
5. İleoçekal valv yetmezliği (ince barsakta dilatasyon).
6. Pnömatozis, serbest hava, duvar kontrastlanmasında azalma.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Çekumda belirgin dilatasyon · iskemi bulguları · perforasyon · çekal volvulus

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Volvulus, iskemi veya perforasyon şüphesinde.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Obstrüksiyon seviyesi, neden, çekum çapı, iskemi ve perforasyon var/yok, bildirim.

Senaryo 27 BATIN

Muayeneyle orantısız şiddetli ağrı: akut mezenterik iskemi

Klinik tablo: Atriyal fibrilasyon, ateroskleroz veya kalp yetmezliği olan yaşlı hastada ani şiddetli ağrı; muayene görece yumuşak.

HANGİ TETKİK?

BT anjiyografi (arteriyel ve portal venöz faz) seçilecek tetkiktir. Kontrastsız seri, kurum protokolüne göre duvar içi kanama ve kalsifikasyon için eklenebilir. Direkt grafi tanıyı geciktirmemelidir.

OKUMA SIRASI

1. Çölyak trunkus ve SMA çıkışı, ardından seyri boyunca dolum defekti.
2. SMV ve portal ven: venöz tromboz.
3. Barsak duvarı: kontrastlanmada azalma, incelme veya kalınlaşma.
4. Pnömatozis, mezenterik ve portal venöz gaz.
5. Diğer organlarda enfarkt (dalak, böbrek): emboli kaynağını düşündürür.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- SMA oklüzyonu · pnömatozis · portal venöz gaz · kontrastlanmayan barsak segmenti

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Mezenterik iskemiden şüphelendiğiniz anda. Zaman bu tanıda en kritik faktördür.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Arteriyel veya venöz oklüzyonun seviyesi, etkilenen barsak segmenti, iskemi bulguları, bildirim saati.

Senaryo 28

BATIN · DAMAR

Karın veya bel ağrısı ve hipotansiyon: rüptüre AAA

Klinik tablo: Yaşlı, sigara içen erkek hastada ani bel veya karın ağrısı, senkop, hipotansiyon; pulsatil kitle.

HANGİ TETKİK?

Hemodinamik olarak stabil olmayan hastada yatak başı USG anevrizmayı gösterebilir; karar klinik ekibe aittir. Stabil hastada BT anjiyografi rüptürü ve tedavi planı için gereken anatomiyi gösterir.

OKUMA SIRASI

1. Aortun en geniş çapını dış duvardan dış duvara ölçün.
2. Retroperitoneal hematom: periaortik yağda kirlenme ve yüksek dansiteli sıvı.
3. Aktif kontrast ekstravazasyonu.
4. Trombus içinde hilal şeklinde hiperdensite (yaklaşan rüptür bulgusu).
5. Renal arterlerle ilişki ve iliyak arterler.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Retroperitoneal hematom · aktif ekstravazasyon · hilal işareti · duvar devamlılığında bozulma

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Rüptür veya yaklaşan rüptür şüphesinde hemen; klinisyeni de eş zamanlı bilgilendirin.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Maksimum çap, uzanım, renal arterlerle ilişki, rüptür bulguları (açıkça var/yok), ekstravazasyon, bildirim.

Senaryo 29 BATIN

Sağ üst kadran ağrısı ve ateş: akut kolesistit

Klinik tablo: Yemek sonrası başlayan sürekli sağ üst kadran ağrısı, ateş, Murphy bulgusu.

HANGİ TETKİK?

USG ilk tetkiktir. BT komplikasyon (gangren, perforasyon, amfizem) şüphesinde veya tanı belirsizse değerlidir. Koledokolitiyazis şüphesinde MRKP kurum protokolüne göre planlanabilir.

OKUMA SIRASI

1. Safra kesesi: taş, boyunda sıkışmış taş, çamur.
2. Duvar kalınlaşması ve perikolesistik sıvı.
3. Probla ultrasonografik Murphy bulgusu.
4. Koledok çapı ve intrahepatik safra yolları.
5. Komplikasyonlar: duvarda düzensizlik, intralüminal membranlar, duvar içi gaz, perforasyon.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Amfizematöz kolesistit · gangrenöz kolesistit · perforasyon ve perikolesistik apse · kolanjit ile uyumlu safra yolu dilatasyonu

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Komplikasyon bulgusu, duvar içi gaz veya safra yollarında dilatasyon ve ateş birlikteliğinde.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Taş, duvar, perikolesistik sıvı, Murphy bulgusu, safra yolu çapı, komplikasyon var/yok.

Senaryo 30 BATIN

Sırta yayılan epigastrik ağrı: akut pankreatit

Klinik tablo: Kuşak tarzı ağrı, kusma; safra taşı veya alkol öyküsü; tanı çoğu zaman klinik ve laboratuvarla konur.

HANGİ TETKİK?

Tanı klinik ve laboratuvarla konmuşsa ilk gün BT her zaman gerekli değildir; safra taşı için USG yapılır. Tanı belirsizse veya klinik kötüleşiyorsa kontrastlı BT istenir. Komplikasyon değerlendirmesi için BT zamanlamasını uzman hocanızla belirleyin.

OKUMA SIRASI

1. Pankreas boyutu, konturu, peripankreatik yağ dokusunda kirlenme.
2. Parankimde kontrastlanmayan alan (nekroz).
3. Peripankreatik sıvı koleksiyonları.
4. Vasküler komplikasyonlar: splenik ven trombozu, psödoanevrizma.
5. Safra taşı ve koledok.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Nekroz · koleksiyon içinde gaz · psödoanevrizma ve kanama · yaygın serbest sıvı

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Kanama, psödoanevrizma veya enfekte nekroz şüphesinde.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Ödematöz veya nekrotizan görünüm, koleksiyonlar, vasküler komplikasyon, safra taşı, eski tetkikle karşılaştırma.

Senaryo 31

BATIN · ÜRİNER

Yan ağrısı ve hematüri: renal kolik

Klinik tablo: Kasığa yayılan kolik tarzda yan ağrısı, bulantı, hematüri.

HANGİ TETKİK?

Kurum protokolüne göre USG (hidronefroz) veya düşük doz kontrastsız BT seçilir; BT taşı ve yerini en doğru gösterir. Gençlerde ve gebelerde USG öncelikli düşünülür. Yaşlı hastada «renal kolik» tablosunda AAA'yı aklınızda tutun.

OKUMA SIRASI

1. Toplayıcı sistemde dilatasyon ve perirenal yağ dokusunda kirlenme.
2. Üreteri pelvisten mesaneye kadar kesit kesit izleyin.
3. Taşın yeri ve boyutu; üreterovezikal bileşkeyi atlamayın.
4. Flebolitten ayırın: taş üreter hattındadır, çevresinde doku halkası olabilir.
5. Alternatif tanılar: apandisit, divertikülit, AAA, over.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Obstrüksiyon ve ateş (ürosepsis riski) · tek böbrek · bilateral obstrüksiyon · forniks rüptürü ve ürinom

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Obstrüktif taşla birlikte enfeksiyon bulgusu veya tek böbrekte obstrüksiyon varsa.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Taşın yeri ve boyutu, hidronefrozun derecesi, perirenal bulgular, alternatif tanı.

Senaryo 32 BATIN

Sol alt kadran ağrısı ve ateş: akut divertikülit

Klinik tablo: Yaşlı hastada sol alt kadran ağrısı, ateş, lökositoz; bilinen divertiküloz olabilir.

HANGİ TETKİK?

Kontrastlı batın BT seçilecek tetkiktir: tanıyı koyar, komplikasyonu gösterir ve ayırıcı tanıyı yapar.

OKUMA SIRASI

1. Divertikülü olan segmentte duvar kalınlaşması ve perikolik yağda kirlenme.
2. Ekstralüminal hava: lokal mi, serbest mi?
3. Apse ve boyutu.
4. Fistül (mesane içinde hava).
5. Uzun segmentte kalınlaşma veya omuzlanma: tümör ayırıcı tanısı.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Serbest perforasyon · apse · fekal peritonit · obstrüksiyon

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Serbest hava veya apse gördüğünüzde.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Tutulan segment, komplike / komplike olmayan ayrımı, apse ve boyutu, serbest hava, tümör ayırıcı tanısı gerekiyorsa kontrol önerisi.

Senaryo 33

BATIN · DAMAR

Aktif gastrointestinal kanama

Klinik tablo: Hematokezya veya melena, hemoglobin düşüşü, hemodinamik instabilite; endoskopi kaynağı gösterememiş olabilir.

HANGİ TETKİK?

Çok fazlı BT anjiyografi (kontrastsız, arteriyel, portal venöz) aktif kanamanın yerini girişimsel tedavi veya cerrahi öncesinde gösterir. Oral kontrast verilmez; ekstravazasyonun görülmesini engeller. Protokolü uzman hocanızla teyit edin.

OKUMA SIRASI

1. Kontrastsız seride lümende hiperdens içerik (yoğun içerik veya yutulmuş materyal; sonraki fazlarla karşılaştırmak için).
2. Arteriyel fazda lümen içinde yeni ortaya çıkan kontrast.
3. Portal venöz fazda bu kontrastın büyümesi ve şekil değiştirmesi.
4. Kanama kaynağı: divertikül, tümör, anjiyodisplazi.
5. Besleyen arter: girişimsel ekip için.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Aktif ekstravazasyon · aortoenterik fistül şüphesi (aort grefti öyküsü) · hemodinamik instabilite

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Protokol öncesinde ve aktif ekstravazasyon gördüğünüz anda; girişimsel radyoloji gerekebilir.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Aktif kanama var/yok, yeri (segment), olası besleyen damar, olası neden, bildirim saati.

Senaryo 34

BATIN · ÜRİNER

Ateş, yan ağrısı ve sepsis: obstrüktif piyelonefrit

Klinik tablo: Ateş, titreme, kostovertebral açı hassasiyeti, hipotansiyon; diyabet veya taş öyküsü.

HANGİ TETKİK?

USG obstrüksiyonu hızla gösterir. Komplikasyon (apse, amfizematöz piyelonefrit) veya neden araştırması için BT, kontrastlı veya kontrastsız olarak kurum protokolüne göre seçilir.

OKUMA SIRASI

1. Hidronefroz ve toplayıcı sistemde ekojenik içerik (piyonefroz).
2. Obstrüksiyonun seviyesi ve nedeni.
3. Parankimde kama şeklinde azalmış kontrastlanma (BT).
4. Renal veya perirenal apse.
5. Parankimde veya toplayıcı sistemde gaz.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Obstrüksiyon ve enfeksiyon birlikteliği · piyonefroz · amfizematöz piyelonefrit · apse

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Enfekte obstrüksiyon veya gaz gördüğünüzde: acil dekompresyon gerekebilir.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Hidronefroz ve derecesi, obstrüksiyon nedeni, gaz ve apse var/yok, bildirim.

Senaryo 35

SKROTUM

Ani skrotal ağrı: testis torsiyonu

Klinik tablo: Genç erkekte ani başlayan şiddetli testis ağrısı, bulantı, kusma; testis yüksek ve yatay olabilir.

HANGİ TETKİK?

Renkli Doppler USG. Torsiyon klinik bir tanıdır: klinik şüphe yüksekse görüntüleme cerrahiyi geciktirmemelidir. Normal Doppler akımı parsiyel torsiyonu tamamen dışlamaz.

OKUMA SIRASI

1. Önce asemptomatik taraf: Doppler ayarlarınızı normal testiste yapın.
2. Aynı ayarlarla etkilenen testiste akım: azalmış veya yok.
3. Testis boyutu, ekojenitesi, konumu.
4. Spermatik kordda girdap işareti.
5. Ayırıcı tanı: epididimit (artmış akım), apendiks testis torsiyonu, travma.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Akım yokluğu veya belirgin asimetri · kordda girdap · heterojen testis

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Torsiyon şüphesinde, raporu beklemeden klinisyenle eş zamanlı. Bulgu belirsizse de arayın.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

İki taraflı karşılaştırmalı akım, girdap işareti, testis ekojenitesi, Doppler ayarlarının aynı tutulduğu, bildirim saati.

Senaryo 36 PELVİS

Ani pelvik ağrı ve kusma: over torsiyonu

Klinik tablo: Gebe olmayan kadında ani tek taraflı pelvik ağrı, bulantı, kusma; bilinen over kisti veya kitlesi olabilir.

HANGİ TETKİK?

Transvajinal veya transabdominal USG ve Doppler. Doppler akımının varlığı torsiyonu dışlamaz; morfoloji daha önemlidir. Önce gebelik testinin bilindiğinden emin olun.

OKUMA SIRASI

1. Overlerin boyutunu iki taraflı karşılaştırın.
2. Büyümüş overde periferik dizilmiş foliküller, stromal ödem.
3. Kitle veya kist (torsiyon için öncü lezyon).
4. Pedikülde girdap işareti.
5. Serbest sıvı; ayırıcı tanı: rüptüre kist, ektopik gebelik, apandisit.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Tek taraflı belirgin büyümüş over · girdap işareti · hemoperiton

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Torsiyondan şüphelendiğinizde ve hemoperiton gördüğünüzde.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Over boyutları, morfoloji, kitle, Doppler bulgusu ve sınırlılığı, serbest sıvı, bildirim.

BÖLÜM 4

Travma

Senaryo 37–44 · Çoklu travma, kafa, omurga, solid organ, pelvis, üriner sistem, kalça.

Senaryo 37

TRAVMA

Yüksek enerjili çoklu travma

Klinik tablo: Trafik kazası, yüksekten düşme; birden fazla bölgede yaralanma şüphesi, hemodinamik durum değişken.

HANGİ TETKİK?

Acil ekip tarafından yatak başında eFAST (serbest sıvı, pnömotoraks, perikardiyal sıvı) yapılır. Stabil hastada kurum protokolüne göre tüm vücut BT (beyin, servikal omurga, toraks, batın, pelvis) istenir. İnstabil hastada karar travma ekibine aittir.

OKUMA SIRASI

1. Önce hayatı tehdit edenler: kafa içi kanama, tansiyon pnömotoraks, aort yaralanması, aktif kanama.
2. Ardından bölge bölge sabit sıra: beyin → servikal omurga → toraks → batın → pelvis → omurga.
3. Her bölgede yumuşak doku ve kemik penceresini ayrı ayrı açın.
4. Tüpler ve kateterlerin yeri.
5. Son olarak kenar alanlar: ekstremiteler, yüz kemikleri.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Aktif ekstravazasyon · aort yaralanması · tansiyon pnömotoraks · kafa içi kanama ve herniasyon · instabil omurga kırığı

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Hayatı tehdit eden ilk bulguyu gördüğünüzde, tüm okumayı bitirmeden; ön bildirimi (ilk okuma) yapın, sonra ayrıntılı rapora devam edin.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Hayatı tehdit eden bulgular raporun başında, ardından bölge bölge yaralanmalar; ön bildirimin saati ve kime yapıldığı.

Senaryo 38

TRAVMA · NÖRO

Kafa travması: epidural ve subdural hematom

Klinik tablo: Düşme veya darbe; bilinç kaybı, lusid aralık, kusma, nöbet veya antikoagülan kullanımı.

HANGİ TETKİK?

Kontrastsız beyin BT; kemik ve beyin pencereleriyle birlikte. Servikal omurga da gerekip gerekmediğini klinik kriterlere göre değerlendirin.

OKUMA SIRASI

1. Ekstraaksiyel koleksiyon: bikonveks (epidural) veya hilal (subdural).
2. Kontüzyon: frontal ve temporal kutuplar, darbe ve karşı darbe alanları.
3. Travmatik SAK ve intraventriküler kan.
4. Kitle etkisi, herniasyon, bazal sisternler.
5. Kemik penceresi: kalvaryum, kafa tabanı, temporal kemik, yüz kemikleri.
6. Pnömosefali ve hava-sıvı seviyesi içeren sinüsler.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Epidural hematom · kitle etkisi yapan subdural · çökme kırığı · kafa tabanı kırığı ve pnömosefali · herniasyon

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Herhangi bir kafa içi kanama, kitle etkisi veya çökme kırığında.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Kanama tipi, yeri, kalınlığı, orta hat kayması, kırıklar, pnömosefali, bildirim saati.

Senaryo 39

TRAVMA · OMURGA

Servikal omurga travması

Klinik tablo: Boyun ağrısı, hassasiyet, nörolojik bulgu veya mekanizma açısından yüksek riskli travma; boyunluk takılı hasta.

HANGİ TETKİK?

Yüksek riskli erişkinde servikal BT seçilecek tetkiktir. Nörolojik defisitte veya bağ ve kord yaralanması şüphesinde MR eklenir; zamanlamayı uzman hocanız ve klinik ekiple belirleyin.

OKUMA SIRASI

1. Kraniyoservikal bileşke: oksipital kondiller, C1, dens.
2. Sagitalde dört hat: ön vertebral, arka vertebral, spinolaminar, spinöz çıkıntılar.
3. Her vertebrayı korpus, pedikül, lamina, faset ve spinöz çıkıntı olarak ayrı ayrı inceleyin.
4. Servikotorasik bileşkeyi (C7–T1) mutlaka görüntüde doğrulayın.
5. Prevertebral yumuşak doku, faset dizilimi.
6. Transvers foramen kırıklarında vertebral arter yaralanması olasılığı.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Dizilim bozukluğu · faset çıkığı · dens kırığı · transvers foramen kırığı · nörolojik defisitle uyumlu bulgu

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Her kırıkta ve emin olmadığınız dizilim bozukluğunda; boyunluğun çıkarılmasına ilişkin karar sizin raporunuza dayanabilir.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Kırık seviyesi ve tipi, dizilim, faset durumu, kanal, transvers foramen tutulumu, MR veya BTA önerisi.

Senaryo 40

TRAVMA · OMURGA

Torakolomber omurga kırığı

Klinik tablo: Yüksekten düşme, trafik kazası; sırt ağrısı, osteoporozlu hastada düşük enerjili travma.

HANGİ TETKİK?

Tüm vücut BT çekilmişse omurga reformatlarından değerlendirilir; ayrıca istenen omurga BT de olabilir. Nörolojik defisitte veya posterior bağ kompleksi şüphesinde MR eklenir.

OKUMA SIRASI

1. Sagital reformatta dizilim ve korpus yükseklikleri.
2. Arka duvarın kanala itilmesi (patlama kırığı).
3. Posterior elemanlar: lamina, faset, spinöz çıkıntılar arası açılma.
4. Birinci kırığı bulduktan sonra ikinci, komşu olmayan kırığı arayın.
5. Paravertebral hematom, eşlik eden organ yaralanması.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Arka duvar retropulsiyonu · translasyon veya distraksiyon · posterior eleman tutulumu · birden fazla seviyede kırık

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

İnstabilite düşündüren her bulguda ve nörolojik defisitli hastada.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Seviye, kırık tipi, kanal daralması, posterior elemanlar, ikinci kırık var/yok, MR önerisi.

Senaryo 41

TRAVMA · BATIN

Künt karın travması: dalak ve karaciğer yaralanması

Klinik tablo: Sol veya sağ üst kadran ağrısı, alt kosta kırıkları, eFAST'ta serbest sıvı; hemodinami değişken.

HANGİ TETKİK?

Stabil hastada kontrastlı batın BT (kurum protokolüne göre arteriyel ve portal venöz fazlar). eFAST serbest sıvıyı gösterir ama organ yaralanmasını derecelendirmez.

OKUMA SIRASI

1. Serbest sıvı ve dansitesi (hemoperiton); en yoğun pıhtının yeri kaynağa işaret eder.
2. Dalak ve karaciğerde laserasyon, subkapsüler hematom.
3. Arteriyel fazda aktif ekstravazasyon ve psödoanevrizma.
4. Portal venöz fazda ekstravazasyonun büyümesi.
5. Böbrek, pankreas, barsak ve mezenter.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Aktif ekstravazasyon · psödoanevrizma · artan hemoperiton · hilus tutulumu

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Aktif kanama veya vasküler yaralanma gördüğünüzde; girişimsel tedavi kararı hızlı verilmelidir.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Yaralanan organ ve yaralanmanın yaygınlığı, vasküler bulgu, hemoperitonun miktarı, eşlik eden yaralanmalar, bildirim.

Senaryo 42

TRAVMA · PELVİS

Pelvis kırığı ve hipotansiyon

Klinik tablo: Yüksek enerjili travma, pelvik instabilite, hemodinamik bozulma; pelvik kuşak takılmış olabilir.

HANGİ TETKİK?

Kurum protokolüne göre ön-arka pelvis grafisi ve kontrastlı BT. Pelvik kuşak varken görüntüleri yorumlarken kuşağın kırık açılmasını azaltabileceğini unutmayın.

OKUMA SIRASI

1. Pelvis halkası: ön ve arka halkada kırık arayın (halka genellikle tek yerden kırılmaz).
2. Simfizis ve sakroiliak eklemlerde açılma.
3. Sakrum: foramenleri izleyerek kırık arayın.
4. Asetabulum.
5. Pelvik hematom ve aktif ekstravazasyon.
6. Mesane, üretra, rektum.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Aktif arteriyel kanama · halkanın açılması · mesane veya üretra yaralanması şüphesi

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Pelvik aktif kanamada hemen: girişimsel radyoloji gerekebilir.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Kırıkların yeri, halkanın stabilitesine ilişkin bulgular, aktif kanama, eşlik eden üriner ve rektal bulgular.

Senaryo 43

TRAVMA · ÜRİNER

Travma sonrası hematüri: böbrek ve mesane yaralanması

Klinik tablo: Künt veya penetran travma, makroskopik hematüri, pelvis kırığı, idrar yapamama.

HANGİ TETKİK?

Kontrastlı BT; toplayıcı sistem yaralanması şüphesinde gecikmiş faz (boşaltım fazı) eklenir. Mesane yaralanması şüphesinde BT sistografi kurum protokolüne göre planlanır. Üretra yaralanması şüphesinde sonda takılmadan önce klinik ekip bilgilendirilmelidir.

OKUMA SIRASI

1. Böbrekte laserasyon, subkapsüler ve perirenal hematom.
2. Renal arter ve ven: kontrastlanmayan böbrek veya segment.
3. Gecikmiş fazda kontrastın toplayıcı sistem dışına kaçışı.
4. Mesane duvarı ve perivezikal sıvı.
5. Sistografide kaçağın intraperitoneal mi ekstraperitoneal mi olduğu.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Renal pedikül yaralanması · aktif ekstravazasyon · idrar kaçağı · intraperitoneal mesane rüptürü

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Gecikmiş faz veya sistografi gerekip gerekmediğine karar verirken ve pedikül yaralanması şüphesinde.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Yaralanmanın derinliği ve toplayıcı sistem tutulumu, vasküler bulgu, kaçak tipi, eşlik eden pelvik kırıklar.

Senaryo 44

TRAVMA · KAS-İSKELET

Yaşlı hastada düşme sonrası kalça ağrısı

Klinik tablo: Basit düşme, kalçada ağrı, yük verememe; bacakta kısalık ve dış rotasyon olabilir veya olmayabilir.

HANGİ TETKİK?

Ön-arka pelvis ve kalçanın yan grafisi. Grafi normal ama klinik şüphe sürüyorsa gizli kırık için MR (tercih edilen) veya BT kurum protokolüne göre önerilir.

OKUMA SIRASI

1. Femur boynu: korteks devamlılığı, trabeküler çizgilerin açılanması, sklerotik bant.
2. Shenton çizgisi ve iki taraflı karşılaştırma.
3. Trokanterik bölge.
4. Pubik ve iskiyal kollar, asetabulum, sakrum.
5. Altta yatan litik veya blastik lezyon (patolojik kırık).

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Deplase boyun kırığı · patolojik kırık · klinik şüpheye rağmen normal grafi

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Patolojik kırık şüphesinde ve gizli kırık için ileri görüntüleme kararında.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Kırık var/yok, yeri ve deplasmanı, kemik dokusu, grafinin gizli kırığı dışlamadığına ilişkin cümle ve ileri görüntüleme önerisi.

BÖLÜM 5

Pediatri ve gebelik

Senaryo 45–50 · Radyasyondan kaçınma, USG önceliği, özel dikkat gerektiren hastalar.

Bu bölümün temel kuralı

Çocuklarda ve gebelerde iyonizan radyasyon gerektirmeyen yöntemler (USG, uygun olduğunda MR) önceliklidir. Ancak gerçekten gerekli bir tetkik radyasyon kaygısıyla ertelenmemelidir. Kararsız kaldığınızda uzman hocanıza danışın.

Senaryo 45 PEDİATRİ

Çocukta sağ alt kadran ağrısı: apandisit

Klinik tablo: Karın ağrısı, kusma, ateş, sağ alt kadran hassasiyeti; küçük çocukta tablo belirsiz olabilir.

HANGİ TETKİK?

USG ilk tetkiktir. USG'de apendiks görülemiyor ve klinik şüphe sürüyorsa yol (gözlem ve tekrar USG, MR veya BT) kurum protokolüne göre uzman hocanız ve çocuk cerrahisiyle belirlenir.

OKUMA SIRASI

1. Lineer probla dereceli kompresyon: en hassas noktadan başlayın.
2. Kör sonlanan, peristaltizmi olmayan, kompresyonla basılmayan tübüler yapı.
3. Duvar ve çevre yağ dokusunun ekojenitesi, Doppler akımı.
4. Apendikolit, serbest sıvı, apse.
5. Alternatif tanılar: mezenterik lenfadenit, invajinasyon, over patolojisi.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Perforasyon ve apse · apendiksin görülemediği yüksek klinik şüphe · invajinasyon

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Apendiks görülemediğinde ve ileri görüntüleme kararında.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Apendiks görüldü/görülmedi (açıkça), bulgular, komplikasyon, alternatif tanı, öneri.

Senaryo 46 PEDİATRİ

Küçük çocukta aralıklı kolik ağrı: invajinasyon

Klinik tablo: Aralıklı şiddetli ağlama atakları, bacaklarını karnına çekme, kusma, letarji; kuş üzümü jölesi görünümünde dışkı geç bulgudur.

HANGİ TETKİK?

USG tanıda seçilecek tetkiktir. Direkt grafi perforasyon veya obstrüksiyon şüphesinde eklenebilir. Redüksiyon kararı ve yöntemi kurum protokolüne göre uzman hocanız ve çocuk cerrahisiyle verilir.

OKUMA SIRASI

1. Tüm kolon hattını sağ alt kadrandan başlayarak tarayın.
2. Aksiyelde iç içe halkalar (hedef görünümü), uzunlamasına kesitte psödoböbrek görünümü.
3. İnvajinasyonun içinde sıvı ve lenf nodları.
4. Duvarda Doppler akımı.
5. Öncü lezyon ve serbest sıvı.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Akımın azalması · serbest hava veya peritonit bulgusu · öncü lezyon

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

İleokolik invajinasyon gördüğünüz anda; redüksiyon planı için.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

İnvajinasyonun tipi ve yeri, Doppler akımı, öncü lezyon, serbest sıvı, perforasyon bulgusu, bildirim.

Senaryo 47 PEDİATRİ

Çocukta yabancı cisim yutma veya aspirasyonu

Klinik tablo: Ani öksürük, boğulma atağı, hırıltı; ya da yutulduğu görülen veya şüphelenilen cisim (madeni para, düğme pil, mıknatıs).

HANGİ TETKİK?

Yutulan cisim için boynu ve tüm gastrointestinal hattı içeren grafi. Aspirasyonda akciğer grafisi (kurum protokolüne göre ekspiryum veya dekübitus grafileri) yapılır; normal grafi aspirasyonu dışlamaz.

OKUMA SIRASI

1. Cismin yeri: özofagus, mide, barsak, hava yolu.
2. Düğme pil ile madeni parayı ayırın: pilin kenarında çift halka (halo) görünümü.
3. Birden fazla mıknatıs veya mıknatıs ile metal birlikteliği.
4. Aspirasyonda tek taraflı hava hapsi, atelektazi, mediastinal kayma.
5. Perforasyon bulguları: serbest hava, pnömomediastinum.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Özofagusta düğme pil · birden fazla mıknatıs · hava yolu yabancı cismi · perforasyon bulgusu

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Özofagusta düğme pil gördüğünüzde hemen; klinisyene de eş zamanlı haber verin. Mıknatıslar ve hava yolu cisimlerinde de beklemeyin.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Cismin yeri ve görünümü, sayısı, düğme pil olasılığı (açıkça), hava yolu bulguları, perforasyon var/yok, bildirim saati.

Senaryo 48

PEDİATRİ

Öyküyle uyumsuz yaralanma: istismar şüphesi

Klinik tablo: Verilen öyküyle açıklanamayan kırık, farklı evrede yaralanmalar, açıklanamayan kafa içi kanama; özellikle küçük bebeklerde.

HANGİ TETKİK?

Kurumunuzun çocuk istismarı protokolü uygulanır (iskelet survey, gerekirse beyin BT veya MR). Görüntüleme kararları ve bildirim süreci protokole ve ekibe göre yürütülür; tek başınıza karar vermeyin.

OKUMA SIRASI

1. Her kemiği ayrı ayrı inceleyin; metafiz köşe kırıkları, arka kosta kırıkları.
2. Farklı iyileşme evrelerinde kırıklar.
3. Kafatası kırığı ve kafa içi kanama; farklı dansitede subdural koleksiyonlar.
4. Batın yaralanmaları.
5. Bulguları nesnel ve tarafsız terimlerle tanımlayın.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Bebekte subdural hematom · arka kosta kırıkları · metafiz köşe kırıkları · farklı evrede çoklu kırık

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

İstismardan şüphelendiğiniz her durumda, rapor yazmadan önce. Bu raporlar adli sonuç doğurabilir.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Her bulgunun yeri ve tahmini evresi (kesin olmayan ifadelerle), öyküyle uyum değerlendirmesinin klinik ekiple yapılması gerektiği, bildirim.

Senaryo 49

GEBELİK

Gebede sağ alt kadran ağrısı: apandisit şüphesi

Klinik tablo: Gebelikte karın ağrısı, bulantı, ateş; büyüyen uterus nedeniyle apendiks yukarı yer değiştirebilir.

HANGİ TETKİK?

USG ilk tetkiktir. USG tanısal değilse kurum protokolüne göre kontrastsız MR tercih edilir. BT gerekiyorsa karar uzman hocanız ve kadın doğum ekibiyle birlikte verilir; gerçekten gerekli tetkik ertelenmemelidir.

OKUMA SIRASI

1. Apendiksi gebelik haftasına göre beklenen yerde arayın.
2. Duvar kalınlaşması, çevre yağda ödem, serbest sıvı.
3. Alternatif tanılar: over torsiyonu, hidronefroz, kolesistit, plasenta ile ilgili patolojiler.
4. MR'da apendiks lümeni ve çevresi (T2 ağırlıklı ve yağ baskılı sekanslar).

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Perforasyon · apse · obstetrik acil olasılığı

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Gebe hastada tetkik seçimi her zaman danışarak yapılmalıdır: istem geldiğinde arayın.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

Gebelik haftası (biliniyorsa), apendiks görüldü/görülmedi, bulgular, alternatif tanı, öneri.

Senaryo 50

GEBELİK

Erken gebelikte ağrı ve kanama: ektopik gebelik

Klinik tablo: Pozitif gebelik testi, pelvik ağrı, vajinal kanama; hipotansiyon rüptürü düşündürür.

HANGİ TETKİK?

Transvajinal USG (yoksa transabdominal). Değerlendirme kadın doğum ekibiyle birlikte ve laboratuvar sonuçları eşliğinde yapılır. İnstabil hastada Morison poşu ve pelviste serbest sıvı hızlıca aranır.

OKUMA SIRASI

1. Uterus içinde gebelik kesesi var mı; içerik (yolk kesesi, embriyo).
2. Adneksler: overden ayrı kitle veya halka görünümü.
3. Douglas boşluğunda serbest sıvı ve ekojenitesi.
4. Morison poşu: yaygın hemoperiton.
5. Atipik yerleşimler: interstisyel, servikal, sezaryen skarı.

KIRMIZI BAYRAKLAR

- Ekojenik serbest sıvı ve hemoperiton · adneksiyel kitle ve boş uterus · Morison poşunda sıvı

UZMAN HOCANIZI NE ZAMAN ARAMALISINIZ

Hemoperiton veya ektopik gebelik şüphesinde; klinisyen ve kadın doğum ekibine eş zamanlı bildirin.

RAPORA MUTLAKA YAZIN

İntrauterin gebelik görüldü/görülmedi, adneksiyel bulgu, serbest sıvının miktarı ve niteliği, bildirim saati. «Lokasyonu belirlenemeyen gebelik» ifadesini gerektiğinde açıkça kullanın.

50 senaryonun ortak dersi

Her senaryoda aynı dört adımı uyguladınız: HAZIRLA, TARA, TANIMLA, ÖZETLE. Acil bulguyu gördüğünüzde önce bildirin, sonra raporu tamamlayın. Bildirimin saatini ve kime yapıldığını her zaman yazın.

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal asistanlık eğitiminin, gözetimin, klinik kararın veya uzman raporunun yerini almaz.

Sonraki adım

Artık her acil tabloda ne yapacağınızı biliyorsunuz. Şimdi sıra aramayı doğru yapmakta.

«Uzmanı Aramadan Önce: 25 Durumda Hazırlık» (Bonus 1) dosyasını açın: uzman hocanızı aramadan önce neyi hazır tutacağınızı ve konuşmayı hangi cümleyle başlatacağınızı adım adım görün.